SDD 41 Sujet n°1

Spécialité : Endocrinologie

Date : 02/10/2023
Auteur : ELAYLI Robin (DES de Psychiatrie - ECN 2023)
Relecteur(s) :

- VILLARD Sébastien (DES de Médecine interne - ECN 2023)
- FILLIOL Clément (DES de Radiologie - ECN 2022)
- SAMANNI Léa (DES d'endocrinologie - ECN 2023)
- VILLETTE Ombeline (DES d'endocrinologie - ECN 2022)

Domaine d'apprentissage principal	Examen clinique
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	ITEM 246 Gynécomastie
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 41 Gynécomastie
Matériel nécessaire à la station	1 bureau, 2 chaises 1 stylo, 1 ordonnance de prescription classique
Contexte de la station	Patient de 35 ans venant pour des masses au niveau des mamelons depuis 1 mois

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes un.e médecin généraliste.
Vous recevez Mr Barte, âgé de 35 ans, dans votre cabinet qui présente des masses au niveau de ses mamelons depuis maintenant 1 mois.
Il ne prend aucun traitement et n'a aucun antécédent particulier. L'interrogatoire du patient ne donne aucune orientation. Vous vous apprêtez à l'examiner.

Consignes :
Vous devez en 7 minutes :

- Faire l'examen clinique nécessaire SAUF sur les zones pectorales, génitales, inguinales ou anales
- Pour les régions citées ci-dessus, vous expliquerez l'examen clinique que vous feriez dessus (sans le faire, si vous pensez qu'il est nécessaire de faire un examen clinique dans ces zones) ainsi que la façon dont vous le feriez
- Prescrire les explorations diagnostiques nécessaires

Vous ne devez pas :

- Refaire l'interrogatoire
- Orienter le patient vers un spécialiste

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
Examen clinique de la gynécomastie			
1.	Dit faire une palpation mammaire bilatérale, sur un patient allongé, en rapprochant le pouce et l'index autour du mamelon	1 pt	☐
2.	Fait une palpation des ganglions cervicaux : ● 1 pt si palpe en se positionnant derrière le patient OU ● 0,5pt si palpe en se positionnant devant le patient)	1pt	☐
3.	Fait une palpation des ganglions sus-claviculaires ET des aisselles (met ses mains au niveau des aisselles du patient et lui demande de refermer ses bras le long du corps, puis palpe la zone en mouvements circulaires)	1pt	☐
4.	Recherche une splénomégalie ET une hépatomégalie (faire une palpation abdominale dans les hypochondres gauche et droit en demandant au patient d'inspirer profondément, en partant d'en bas (fosses iliaques))	1pt	☐
5.	Dit faire une palpation testiculaire	1 pt	☐
Prescription des explorations diagnostiques			
6.	Prescrit une échographie testiculaire (1.5)	1,5 pt	☐
7.	Prescrit le dosage de la TSH ET de la T4 libre (Perd 0,5 pt si prescrit la T3)	1 pt	☐
8.	Prescrit le dosage de (0,5 par élément) : ● Testostérone totale ● LH et FSH ● Prolactine ● Oestradiol ● HCG totaux	2,5 pt	☐
9.	Prescrit un ionogramme sanguin ET une créatininémie	1 pt	☐
10.	Prescrit l'échographie et le bilan sanguin sur 2 ordonnances distinctes	1 pt	☐

Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)	
1.	**9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE**

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

2.	**10. APTITUDE À MENER L'EXAMEN CLINIQUE**

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'explique pas au patient les gestes réalisés ou ne respecte pas le confort du patient	Explique peu les gestes réalisés	Explique les gestes réalisés et respecte le confort du patient	Donne l'information sur les gestes en expliquant les objectifs /les éléments recherchés et respecte le confort du patient	Agit sans erreur Met à l'aise

TOTAL (max 20 items)	/14 points

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)

Pathologie recherchées devant une gynécomastie :

Evocable par le contexte/ la clinique	- Cause iatrogène (médicamenteuse, dont la liste est dans le cours de Gynécomastie*) - Insuffisance rénale chronique - Cirrhose - Renutrition de patient dénutri
Plus rare	- Hyperthyroïdie - Tumeur sécrétante (TSH, E2, prolactine, HCG) - Tumeur non sécrétante (testiculaire, hypophysaire) - Hypogonadisme périphérique (de cause le plus souvent génétique)

**Les essentiels à retenir dans un 1er temps (les autres sont aussi à connaître mais ce sont les 3 les plus fréquents) sont :*

- *Spironolactone*
- *Neuroleptique (rispéridone, halopéridol, amisulpride, alanzapine)*
- *Kétoconazole*

Pathologie	Élément orientant	Examen complémentaire de 1ère intention
IRC	- Oedème membres inférieurs - Voir clinique IRC	- Bilan biologique rénal* (créatininémie + DFG)
Cirrhose	- Voir clinique de cirrhose	Le contexte évident ne nécessite des explorations que si suspicion de cirrhose
Tumeur	- Anomalie à la palpation testiculaire - Adénopathie	- Echographie testiculaire - Dosage HCG totaux - Dosage FSH/LH - Dosage E2 - Dosage Testostérone
Hyperthyroïdie	- Goitre - Orbitopathie de Basedow - Autres signes d'hyperthyroïdie	- Dosage TSH et T4L - Echographie thyroïdienne si goitre
Hypogonadisme	- Testicule petit et mou - Raréfaction/faible pilosité - Si par hyperprolactinémie, possible galactorrhée	- Dosage LH, FSH - Dosage testostérone

**Même s'il n'y a pas de signes d'IRC, il est conseillé de le faire en routine*

Dans les tumeurs que l'on peut suspecter :

Tumeur		*Localisation*
Tumeur sécrétante	***E2***	*- Majoritairement au niveau testiculaire (ce qui explique l'échographie testiculaire à toujours faire)*
	HCG	*- Testiculaire (tumeur germinale maligne testiculaire)* *- Hypothalamique (germinome hypothalamique)*
	Prolactine	*- Hypophyse (hyperprolactinémie de sécrétion)*
	TSH	*- Hypophyse (hyperthyroïdie centrale mais rare ++)*
Tumeur non sécrétante		*- Hypophysaire :* ● *Par hyperprolactinémie de déconnexion* ● *Par déficit gonadotrophique*

ATTENTION : On ne recherche pas d'adénopathie inguinale pour le cancer testiculaire car ce dernier se draine en rétro-péritonéal donc il faut rechercher un ganglion de Troisier.

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et répond « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Monsieur Barte, 35 ans, consulte en cabinet de médecine générale pour des masses au niveau de ses mamelons, apparues depuis 1 mois
L'interrogatoire ne révèle aucune orientation de diagnostic (ne prend pas de traitement, pas d'antécédent, pas de signe à l'interrogatoire d'une pathologie)

Plan de la station ECOS :

Un bureau avec 2 chaises. L'acteur.trice s'asseoit en face des candidats.es

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

-" Très bien docteur je vous laisse m'examiner"

Identité du patient :

Mr Barte, 35 ans
Homme
1m92, 90 kg

Mode de vie :

Marié, 1 enfant
Ingénieur en mécanique des fluides
Pas d'alcool, pas de tabac, pas de drogue, pas de cannabis
Allergie aux pollens

Comportement global :

Calme, se laisse faire

Antécédents personnels :

Aucun

Antécédents familiaux :

Aucun

Médicaments :

Aucun

Symptômes positifs :

- Si l'étudiants.es palpe les ganglions (au niveau des aisselles, du cou, d'au dessus de la clavicule) : Lui dire qu'il n'y a pas de ganglion perçu à la palpation
- Si l'étudiants.es palpe le foie (au niveau de l'abdomen droit haut - *sachant que l'étudiant.e doit commencer à palper depuis le bas droit du ventre*) : lui dire qu'il n'y a pas d'hépatomégalie
- Si l'étudiants.es palpe la rate (au niveau de l'abdomen gauche haut - *sachant que l'étudiant.e doit commencer à palper depuis le bas central / gauche du ventre*) : lui dire qu'il n'y a pas de splénomégalie
- Si l'étudiants.es vous dit (NE DOIT PAS LE FAIRE, JUSTE LE DIRE) qu'il va palper les testicules, dire que la palpation est normale
- Si l'étudiants.es vous dit (NE DOIT PAS LE FAIRE, JUSTE LE DIRE) qu'iel va palper les pectoraux, demander comment iel va faire, puis lui dire qu'iel perçoit une masse ferme, mobile, arrondi, centré sur le mamelon des deux côté, et qu'il n'y a pas de galactorrhée

Questions de relance :

- 2 minutes avant la fin, lui demander "qu'allez vous me prescrire pour savoir d'où cela provient ?"
- Si dit faire une palpation mammaire, lui dire : " comment est-ce que vous allez la faire ?"
- Si commence à vous interroger, lui dire "ah je pensez que vous alliez juste m'examiner et que l'interrogatoire était fini"

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Patient en face des candidats.es, de part et d'autres d'un bureau

Matériel nécessaire à la station :

- *Feuille de brouillon pour candidat*
- *Ordonnance de prescription classique*
- *Stylo pour candidat*
- *Feuille de brouillon pour évaluateur*
- *Stylo pour évaluateur*

Documents présents dans la station :

- *Feuilles d'évaluation de papier de secours*
- *Ordonnance de prescription classique*